3.1.6.1. 욕창관리

제 정 일	2012.10.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	간호국				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 2.2.2. 입원환자 초기평가/재평가, 3.1.6. 욕창관리 JCI Standard 7th Edition: AOP.1, 1.1, 1.2, 2, COP.3, GLD.11

제1조 (목적)

1. 욕창으로 발생되는 환자상해를 예방 및 감소시키고, 욕창 환자 관리에 대한 지침을 제공하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 욕창(Pressure injury): 뼈 돌출부에 압력 및/또는 전단력이 결합된 결과로 피부 및/또는 하부조직에 생긴 국소적 손상

제3조 (절차)

1. 욕창 위험도 평가
   1) 평가대상: 모든 입원환자
   2) 평가도구
      (1) 12개월 이상 환자의 욕창 위험도 평가는 'Braden Scale과 위험요인'으로 평가
      (2) 12개월 미만 영유아기 환자의 욕창 위험도 평가는'Neonatal/Infant Braden Q scale'로 평가
   3) 평가주기
      (1) 초기평가: 입원 시
      (2) 재평가
         ① 상태변화 없을 시: 1회/주
         ② 상태변화 있을 시, 추가로 재평가를 시행한다.
         ③ 재평가 사유: 수술, 침습적 시술, 이동, 장애 발생 시
         ④ 중환자실(신생아 집중치료실, 신생아실 포함): 1회/일 시행한다.

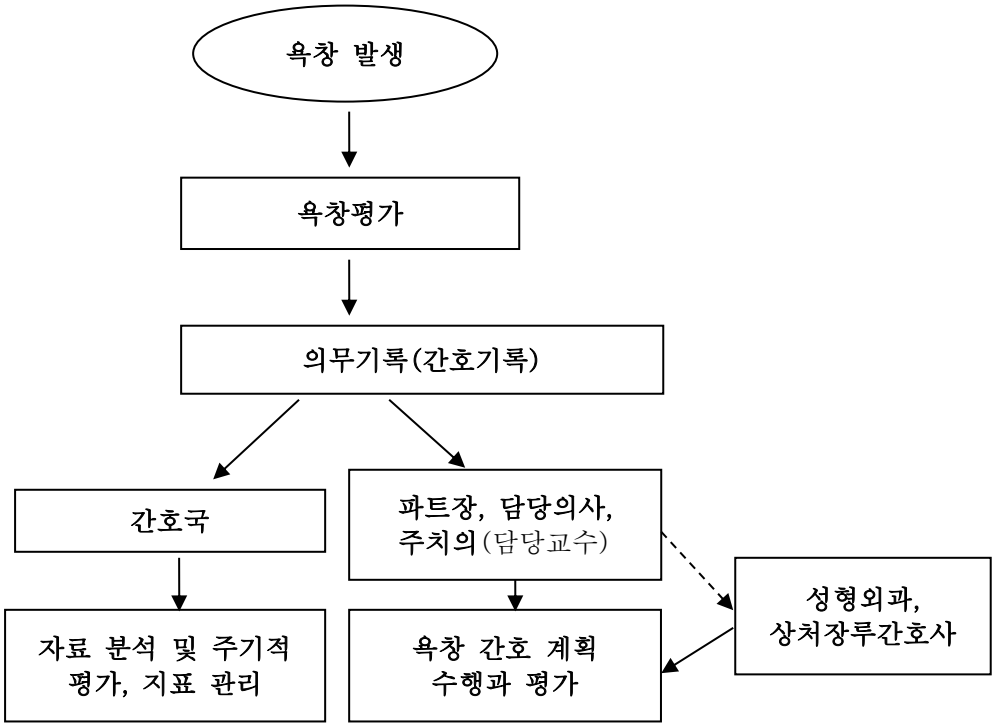
2. 욕창 위험 분류 기준
   1) 욕창발생위험군
      (1) 12개월 이상 환자: 18점 이하
      (2) 12개월 미만 영유아기 환자: 19점 이하

3. 욕창 예방활동
   1) 대상: 욕창 발생 위험군 및 욕창 발생 환자군

2) 내용: 매일 피부상태 관찰, 자세 변경, 필요 시 기타 예방활동(예: 매트리스 적용, 발뒤꿈치 상승, 드레싱 및 피부관리 제품 적용 등)을 시행한다.
3) 간호기록: 욕창 발생 위험군은 '피부 통합성 장애의 위험', 욕창 발생 환자군은 '피부 통합성 장애'로 간호진단을 수립하고 욕창 예방활동 내용을 기록한다.
4) [부록1. 욕창 예방 관리지침]에 따라 예방 활동을 시행한다.

4. 욕창관리
1) 욕창 위험도 평가 결과에 따라 욕창 예방활동, 욕창 발생 시 욕창 관리활동 및 욕창 발생보고를 한다.
2) 욕창 발생 위험군인 경우 욕창 발생 위험군 환자임을 효과적으로 의사소통한다.
(1) 인수인계하고 욕창 발생 위험군 환자임을 팔찌에 표시하여 정보를 공유한다.
3) 욕창 간호
(1) 대상: 욕창 환자
(2) 내용: 욕창 부위, 단계, 필요 시 크기(머리~다리 방향의 최대길이 X 최대너비 X 깊이: cm) 등을 평가 및 기록하고, 간호계획에 따라 욕창 간호를 제공한다. 욕창 간호란 재평가, 소독(드레싱), 수술 등
(3) 의학적 또는 간호계획을 포함한 욕창의 치유를 위해 제공하는 간호행위이다.
(4) 필요 시 성형외과 또는 전문간호(상처장루) 협의진료를 의뢰하여 욕창 관리활동을 수행한다.

5. 욕창 발생 관리체계
1) 욕창발생 기록: [u-Severance] - [기록] - [간호기록]
2) 관리체계: [그림1. 욕창 발생 관리 체계]에 따른다.



[그림1. 욕창 발생 관리 체계]

6. 욕창 관리활동 평가
   1) 욕창 관리활동(발생건수, 발생률, 유병률, 욕창으로 인한 상해의 심각성)을 주기적으로 모니터링하며, 결과에 따른 개선활동을 시행한다.
   2) 분기별로 욕창 관리 성과를 병원운영위원회 및 세브란스병원장에게 보고하며, 관련 직원과 공유한다.

제4조 (부록)

1. 욕창 예방 관리지침

제5조 (참고)

1. National Pressure Ulcer Advisory Panel & European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pain Pacific Pressure Injury Pressure Ulcer Alliance(2014). Prevention and treatment of pressure ulcers: Clinical practice guideline. Emily Haesler (Ed). Cambridge Media: Perth, Australia.
2. McLane, K. M., Bookout, K., McCord, S., McCain, J., & Jefferson, L. S. (2004). The 2003 national pediatric pressure ulcer and skin breakdown prevalence survey: a multisite study. Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing, 31(4), 168-178.
3. Bergstrom, N., & Braden, B. (1992). A prospective study of pressure sore risk among institutionalized elderly. Journal of the American Geriatrics Society, 40(8), 747-758.
4. Braden, B. J., & Bergstrom, N. (1989). Clinical utility of the Braden Scale for predicting pressure sore risk. Advances in Skin & Wound Care, 2(3), 44-51.
5. European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed.). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019.
6. 병원간호사회. (2022) 근거기반 임상간호실무지침. 욕창간호, 55-56

내규의 제·개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2012년 10월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인 : 세브란스병원장 이 강 영 (인)